

B37_ Apport de la biochimie médicale dans le diagnostic précoce d'une rhabdomyolyse chez un polytraumatisé : à propos d'un cas.

N. LOUAILECHE, S. KENDRI, F. CHIKHI , L. BOULEGANE, F. DJABI

Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas –Sétif 1–
Laboratoire central, CHU de Sétif.

Introduction :

Le polytraumatisme est une urgence médico-chirurgicale majeure, associée à une morbi-mortalité élevée et nécessitant une prise en charge multidisciplinaire rapide. Si l'évaluation clinique et l'imagerie demeurent indispensables, la biologie occupe une place centrale dans la prise en charge en apportant des informations précoces sur les conséquences cellulaires et systémiques du traumatisme. L'interprétation des biomarqueurs biologiques constitue ainsi un élément clé de l'évaluation initiale et du suivi des patients polytraumatisés.

Objectifs :

L'objectif de ce travail est d'illustrer l'apport de la biochimie médicale dans la prise en charge du patient polytraumatisé à travers une interprétation intégrée des biomarqueurs, permettant un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée.

Observation :

Nous rapportons le cas d'un homme de 19 ans, sans antécédents médico-chirurgicaux, victime d'un accident de la circulation responsable d'un polytraumatisme grave, admis au Bloc des Urgences Chirurgicales du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Sétif.

À l'admission, le patient présentait un choc hémorragique (TA : 70/40 mmHg ; FC : 120 bpm). Le scanner thoraco-abdomino-pelvien objectivait un traumatisme hépatique grade IV selon American Association for the Surgery of Trauma (AAST) avec hémopéritoine abondant, associé à un pneumothorax bilatéral partiel, des contusions pulmonaires et des fractures multiples. Le bilan biologique initial était principalement orienté vers l'évaluation de la cytolyse hépatique .

À J3, une élévation importante des aspartate aminotransférases (ASAT) (378,4 U/L) et des alanine aminotransférases (ALAT) (744,1 U/L) a été observée. Après s'être renseigné sur le contexte clinique auprès de l'équipe soignante, le biochimiste médical a évoqué une atteinte musculaire associée et a pris l'initiative de compléter le bilan, sur les prélèvements déjà disponibles au laboratoire, par le dosage des créatine kinases (CK) totales et de la lactate déshydrogénase (LDH). L'élévation majeure des CK (5 165 U/L) et de la LDH (820 U/L) a permis de retenir le diagnostic de rhabdomyolyse aiguë jusque-là non suspectée, associée au traumatisme hépatique. Une hyperkaliémie modérée (5,21 mmol/L) était également observée .

Une hyperhydratation préventive a été instaurée dès J3. La cinétique des biomarqueurs enzymatiques (Figure 1) a montré une régression progressive des CK, de la LDH et des transaminases, avec une évolution favorable et préservation de la fonction rénale .

Fonction rénale préservée :

- créatinine 26 mg/L à J1, puis 5,1–9 mg/L au cours du suivi .
- urée 0,35 g/L à J1, avec un pic à 0,59 g/L à J5 puis une diminution à 0,23–0,24 g/L à J16–J24 .

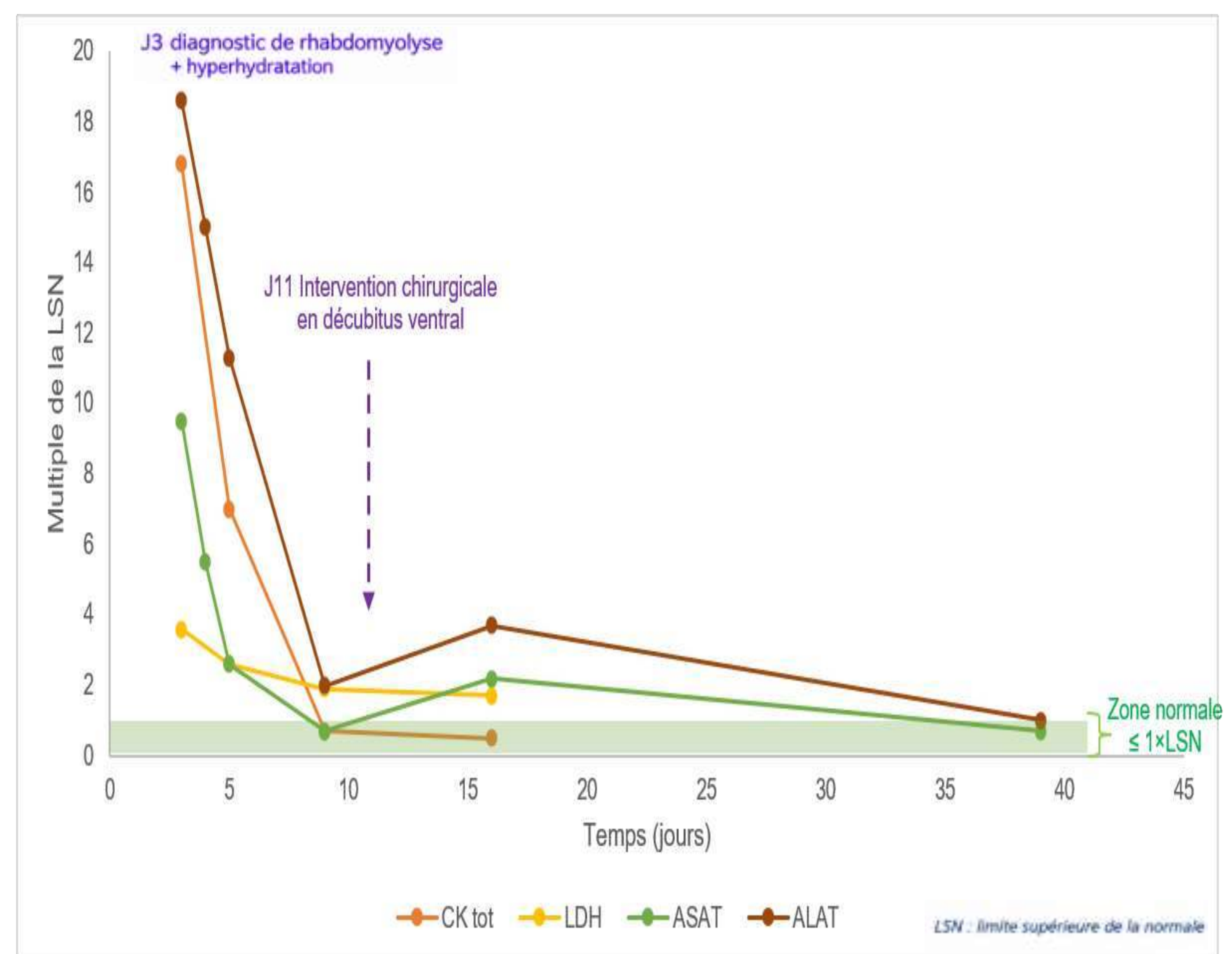


Figure 1: Évolution des biomarqueurs enzymatiques sériques au cours du suivi

Discussion :

Le polytraumatisme peut associer des atteintes hépatiques et musculaires, rendant l'interprétation des transaminases parfois complexe. Chez notre patient, l'élévation des ALAT (744 U/L) et des ASAT (378 U/L) pouvait être expliquée par la cytolyse hépatique liée au traumatisme hépatique AAST grade IV objectivé au scanner. Toutefois, dans ce contexte de polytraumatisme avec lésions musculaires multiples, une contribution musculaire, notamment à l'élévation des ASAT, devait également être envisagée.

Le biochimiste médical a ainsi pris l'initiative de compléter le bilan, sur les prélèvements déjà disponibles au laboratoire, par le dosage des CK et de la LDH. Leur élévation majeure (CK : 5 165 U/L ; LDH : 820 U/L) a permis d'identifier une rhabdomyolyse aiguë associée au traumatisme hépatique.

Cette détection précoce a permis l'instauration d'une hyperhydratation préventive, visant à limiter le risque de complications rénales liées à la libération de myoglobine.

L'hyperkaliémie transitoire (5,21 mmol/L) était compatible avec la libération du potassium intracellulaire secondaire à la lyse musculaire. L'évolution de la fonction rénale est restée favorable au cours du suivi. La créatinine, élevée à 26 mg/L à J1, s'est stabilisée entre 5,1 et 9 mg/L par la suite. L'urée était à 0,35 g/L à J1, avec une élévation transitoire à 0,59 g/L à J5, suivie d'une diminution à 0,23–0,24 g/L entre J16 et J24. Aucune évolution vers une insuffisance rénale aiguë n'a été observée.

La décroissance progressive des CK et de la LDH jusqu'à J16 témoignait de l'évolution favorable de la rhabdomyolyse. Une réascension modérée et transitoire des transaminases après la chirurgie rachidienne en décubitus ventral (ASAT : 2,2 × LSN ; ALAT : 3,7 × LSN) a ensuite été observée, avant leur normalisation à J39.

Conclusion :

Cette observation souligne l'importance d'une interprétation intégrée et dynamique des résultats biologiques et du dialogue clinico-biologique. Elle met en évidence la valeur ajoutée du biochimiste médical dans la détection précoce d'une rhabdomyolyse associée, permettant d'orienter rapidement la prise en charge et de contribuer à la prévention de ses complications rénales.